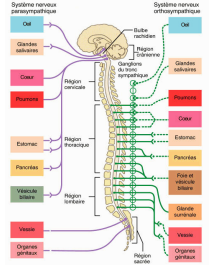


CHOC NEUROGÉNIQUE



I-Introduction :

*C'est une complication d'un **traumatisme médullaire** impliquant généralement **le rachis cervical**.

II-Physiopathologie :

*Le SN sympathique émerge au niveau médullaire et le parasympathique au niveau bulbaire et suit le trajet du nerf vague.

*Toute section médullaire entraîne une interruption de l'innervation sympathique supra-spinale mais le parasympathique est épargné → **Vasoplégie, défaut d'adaptation chronotrope et inotrope du myocarde, Hypotension, Troubles de conduction AV.**

III-Clinique :

*Causes (interrogatoire): Chute, AVP, accident de plongée...

*Clinique : Vasoplésie, bradycardie, hypotension, tétraplégie, IR aigue (nerf phrénique)

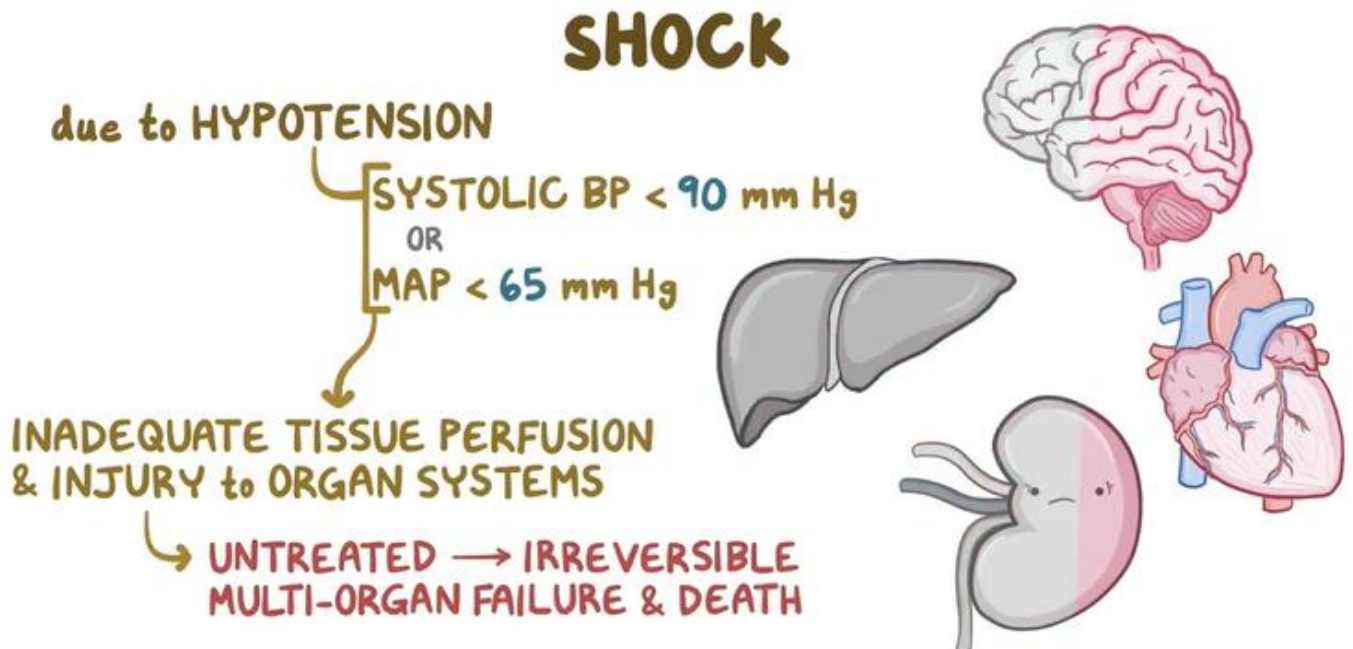
IV-Traitement :

*ABCDE,

*Immobilisation du rachis,

*Traitement symptomatique : normoxie, normocapnie, température correcte,

*Traitement chirurgical.



* RESUSCITATION should NOT be DELAYED if CENTRAL VENOUS ACCESS NOT AVAILABLE

↳ "FLUID CHALLENGE"

↳ MAP or URINE OUTPUT

RESPONSE to FLUIDS	
HYPOVOLEMIC SEPTIC	✓
CARDIOGENIC OBSTRUCTIVE	✗

IV CRYSTALLOID FLUID



ASSESS RESPONSE to FLUIDS